

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	心肺復甦術評核表	編號	A31000-Q06-F-B30
			版本	第 2.5 版
	制定單位	護理部	修正日期	114 年 09 月 15 日
			頁數/總頁數	1/2

一、評核對象：全院各單位護理人員（含中興分院）。

（小兒單位不適用：R11、R10、NI、PI、IR、BR）

二、評核方式：以口述或實際演練方式表現其對心肺復甦術之護理觀念與技術。

三、評核內容：

- 1.（安）確認急救現場安全無虞。
- 2.（叫）檢查意識：叫喚並輕拍病人肩部，確定有無意識，檢查呼吸—沒有呼吸或沒有正常呼吸
- 3.高聲呼救，若醫師無法立即到達，請旁人打 39595 請總機 call 9595 及推急救車至病患單位並放置急救板於患者背部。
- 4.摸頸動脈，檢查時間 10 秒（食指與中指先摸到喉結處，再滑進同側氣管和頸部肌肉所形成之溝中，即可觸摸到頸動脈之脈動）。
- 5.無脈搏立即正確找出心臟按摩位置：胸骨下半段，兩乳間胸骨上或兩乳頭連線中央。
- 6.正確按壓手勢及姿勢：
 - a.雙手重疊，手指不可接觸到胸部。
 - b.手腕與手肘需打直，雙肩向前傾至手部之正上方，以身體重量垂直向下按壓，壓力平穩不可使用瞬間壓力。
 - c.放鬆時身體不再向下用力，但手掌不可離開胸骨。
- 7.正確按壓深度：至少 5 公分（2 英吋）但不超過 6 公分（2.4 英吋）。
- 8.正確按壓速率：每分鐘至少 100-120 下。
- 9.按壓與放鬆有節奏，時間各佔 50%（按壓方法：「用力壓且快速壓」讓按壓深度完全回彈）。
- 10.視呼吸情況予 100%O₂Mask Ambu Bagging，一口氣一秒。
- 11.按壓：吹氣比例-無論單人或雙人 CPR，壓胸與給予呼吸之比為 30：2，插管後每分鐘 10 次的 bagging（約 6 秒按一次）。（SOP 寫 10 次）
- 12.在 5 個循環後再檢查有無循環現象，如無循環現象，繼續心臟按摩；如有循環現象，則檢查呼吸 3~5 秒，並視情況準備插管。
- 13.選擇適合的口腔氣管內管並用 10ml 針筒測試口腔氣管內管前端之氣囊是否漏氣。
- 14.將通條放入氣管內管，於前端塗上少許 xylocaine jelly。
- 15.插管的時間不可超過 20 秒，若失敗或超過 20 秒立即給予 100%氧氣和標準的通氣 15~30 秒後再試一次。
- 16.插管確定位置後，打入 5~8 cc 氣體，固定氣囊，維持壓力 15~25 cm H₂O。
- 17.沒有脈搏的 VT、VF＝電擊一次，接著 CPR 5 個循環（約 2 分鐘），檢查心律是否要繼續電擊；若要則再電擊。接著 CPR 5 個循環，檢查心律是否再電擊。

